

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO BREVE DE EVITACIÓN EXPERIENCIAL (BEAQ-15)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de la Evitación Experiencial y Rigidez Psicológica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario Breve de Evitación Experiencial (BEAQ-15).
Nombre Original (Inglés)	<i>Brief Experiential Avoidance Questionnaire (BEAQ)</i>
Autores Originales	Drs. W. Gámez, K. Chmielewski, M. A. Kotov, D. Ruggero y D. Watson (2014).
Validación Española / LatAm	Antonio J. Vázquez-Morejón, Raquel Vázquez-Morejón Jiménez et al. (2019, <i>Psicothema</i>).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Inflexibilidad Psicológica.
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 15 reactivos con escala Likert de 6 puntos (1 a 6).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde 16 años). Específicamente baremado en salud mental ambulatoria.
Tiempo de Administración	2 a 4 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, docencia e investigación científica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TRANSDIAGNÓSTICO ACT

En el modelo de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes et al., 2006), la **evitación experiencial (EE)** es definida como el intento inflexible e infructuoso de suprimir, escapar o alterar la frecuencia, forma o intensidad de vivencias privadas indeseadas (pensamientos dolorosos, afectos aversivos, recuerdos traumáticos o sensaciones corporales), a pesar de los severos costes conductuales y la pérdida de contacto con valores personales significativos.

El BEAQ surge a partir del Cuestionario Multidimensional de Evitación Experiencial (MEAQ de 62 reactivos; Gámez et al., 2011) mediante rigurosos análisis factoriales y de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Se diseñó para subsanar las principales debilidades psicométricas del AAQ-II, el cual tiende a solaparse de manera excesiva con el distrés emocional general y el neuroticismo rasgo. El BEAQ ofrece una medida más limpia, conductual y multifacética de las estrategias evitativas directas, sin depender de la mera presencia del afecto negativo. A nivel neurobiológico, la evitación experiencial refleja un déficit de modulación top-down cortico-límbica (hipoactivación prefrontal ventromedial y córtex cingulado anterior con hiperreactividad amigdalina sostenida).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión / Faceta del MEAQ	Ítems (15)	Sentido	Definición Operativa y Conducta Evaluada
1. Retirada Conductual	2, 7, 8, 11, 14	Directos (5)	Abandono o rechazo de actividades ante cualquier posibilidad de displacer.
2. Aversión al Malestar	1, 12, 13, 15	Directos (4)	Intolerancia a las sensaciones dolorosas y creencia de que sufrir es inaceptable.
3. Supresión / Desconexión	3, 4, 9	Directos (3)	Intentos activos de desterrar recuerdos amargos y alienación de las emociones.
4. Procrastinación Evitativa	5, 10	Directos (2)	Demora sistemática y postergación de tareas incómodas o desafiantes.
5. Aceptación Comprometida	6	Inverso (1)	Disposición a actuar según valores a pesar del miedo o la ansiedad.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Óptima homogeneidad métrica: alfa de Cronbach de 0.82 en muestra clínica española (N = 332 pacientes ambulatorios de salud mental; Vázquez-Morejón et al., 2019). Estabilidad test-retest $r = 0.70$ a los 6 meses de seguimiento.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica una sólida solución unidimensional de segundo orden (CFI = 0.93, TLI = 0.91, RMSEA = 0.058), justificando plenamente el cómputo de una puntuación global única.
Validez Concurrente y Convergente	Alta correlación con el AAQ-II ($r = 0.67$, $p < .001$). Correlaciones directas moderadas con depresión (BDI-II, $r = 0.52$) y ansiedad (STAI, $r = 0.58$). Correlación inversa con calidad de vida (SF-12, $r = -0.48$).
Validez Incremental	El BEAQ demostró explicar un 14% de varianza única de discapacidad funcional tras controlar estadísticamente las dimensiones de afecto negativo y neuroticismo del NEO-PI-R.
Sensibilidad al Cambio Clínico	Excelente responsividad en tratamientos basados en ACT, con descensos de magnitud media-alta (d de Cohen = 0.85 a 1.15) tras la intervención terapéutica.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo se puntúa de 1 (**Totalmente en desacuerdo**) a 6 (**Totalmente de acuerdo**):

- **Paso 1 (Inversión Obligatoria del Ítem 6):** El ítem 6 ("El miedo o la ansiedad no me impedirán hacer las cosas importantes") debe invertirse: Puntuación = 7 - Respuesta (1 → 6, 2 → 5, 3 → 4, 4 → 3, 5 → 2, 6 → 1).
- **Paso 2 (Puntuación Total):** Se suman los 14 ítems directos más el ítem 6 invertido.
- **Rango Teórico Global: 15 a 90 puntos.** Mayor puntaje = mayor rigidez psicológica y severidad de la evitación experiencial.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (VÁZQUEZ-MOREJÓN ET AL., 2019)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Evitación	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo / Adaptativo	15 a 39 puntos	Aceptación psicológica abierta	Flexibilidad conductual preservada. Disposición a tolerar distrés en persecución de metas y valores vitales.
Moderado	40 a 54 puntos	Evitación subclínica / reactiva	Aparición de patrones evitativos ante crisis o sobrecargas estresantes. Psicoeducación preventiva en ACT.
Clínico / Elevado	55 a 67 puntos	Evitación clínicamente significativa (corte ≥ 55)	Rigidez psicológica manifiesta; deterioro funcional moderado. Indicación formal de intervención basada en ACT.
Severo / Extremo	68 a 90 puntos	Rigidez e inflexibilidad invalidante	Retirada social y conductual generalizada; parálisis por malestar; altísimo riesgo de cronificación.

BAREMOS CLÍNICOS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA (N = 332):

En la validación española de Vázquez-Morejón et al. (2019), la media en pacientes clínicos ambulatorios fue de **55.60 (DE = 13.92)** frente a **42.10 (DE = 12.30)** en población comunitaria. El **punto de corte de ≥ 55 puntos** maximiza la sensibilidad diagnóstica (0.78) y especificidad (0.75) para discriminar presencia de psicopatología severa con rigidez transdiagnóstica.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN INFLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA (ACT)

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ACT BASADO EN EL BEAQ-15:

- **Paso 1 (Desesperanza Creativa):** Analizar el coste vital de las estrategias de evitación. Demostrar vivencialmente cómo el control de las emociones es el problema, no la solución (ejercicio de las arenas movedizas).
- **Paso 2 (Defusión y Aceptación):** Si puntúan alto en Supresión (ítems 3, 4, 9), entrenar defusión ("notar el pensamiento como un evento mental transitorio"). Si predomina Retirada Conductual (ítems 2, 7, 8), ejercicios de exposición disposicional.
- **Paso 3 (Acción Guiada por Valores):** Clarificar valores nucleares y establecer compromisos conductuales graduados. Un descenso de **≥ 12 puntos** en el BEAQ al cabo de 8 a 10 semanas evidencia ganancia robusta en flexibilidad psicológica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DE PÁNICO CON AGORAFOBIA

Identificación: Varón de 41 años, empleado administrativo, acude por crisis de pánico recurrentes y conducta agorafóbica restrictiva de 2 años de evolución. Evita el transporte público, centros comerciales y reuniones sociales.

Evaluación Inicial BEAQ (Línea Base): Puntuación Total = **74 puntos** (Rango Severo / Extremo). Elevación casi máxima en retirada conductual (ítems 2, 7, 8, 11 puntuados con 6), aversión al malestar (ítem 1 y 15 = 6) y escasa disposición a actuar con miedo (ítem 6 invertido = 6).

Intervención Aplicada: Protocolo de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Se suspendieron las conductas de seguridad y se realizaron ejercicios de exposición interoceptiva voluntaria en sesión vinculados a su valor fundamental de paternidad activa (llevar a sus hijos al parque).

Reevaluación a las 10 Semanas: Puntuación Total BEAQ = **41 puntos** (reducción neta de 33 puntos, transición al rango Moderado / Subclínico). El paciente recuperó desplazamientos autónomos en tren y refirió: "El miedo sigue apareciendo a veces, pero ya no decido mi vida en función de él".

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EVITACIÓN VS. PRUDENCIA ADAPTATIVA:

No toda evitación es patológica. En contextos de violencia intrafamiliar activa, ambientes laborales tóxicos o peligro físico inminente, evitar situaciones amenazantes es una respuesta adaptativa de autoprotección básica y no una rigidez psicológica disfuncional.

DESCARTE DE ANHEDONIA Y DEPRESIÓN GRAVE:

Puntuaciones muy altas en retiro conductual (ítems 2 y 8) pueden coexistir con anhedonia mayor y enlentecimiento psicomotor. Es imprescindible evaluar riesgo autolítico colateral (C-SSRS) si la evitación está motivada por desesperanza terminal.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Vázquez-Morejón, A. J., Vázquez-Morejón Jiménez, R., & León-Rubio, J. M. (2019). Psychometric properties of the Brief Experiential Avoidance Questionnaire (BEAQ) in a Spanish clinical sample. *Psicothema*, 31(4), 463-469.
2. Gámez, W., Chmielewski, M., Kotov, R., Ruggero, C., & Watson, D. (2014). The Brief Experiential Avoidance Questionnaire: development and initial validation. *Psychological Assessment*, 26(1), 35-45.
3. Gámez, W., Chmielewski, M., Kotov, R., Ruggero, C., & Watson, D. (2011). Development of a measure of experiential avoidance: the Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire. *Psychological Assessment*, 23(3), 692-713.
4. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. *Behaviour Research and Therapy*, 44(1), 1-25.